



## PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

### Protocolo 35 — Atendimento à Pessoa em Situação de Violência: violência doméstica/interpessoal (Lei Maria da Penha), violência sexual (profilaxias em ≤72 h), violência contra criança/adolescente, idoso e pessoa com deficiência, e violência autoprovocada

Acolhimento, registro e documentação, profilaxias (HIV, IST, hepatite B, gravidez), notificação compulsória (SINAN), comunicação obrigatória (Conselho Tutelar, autoridade policial), rede de proteção e alta segura — cenário: pronto-socorro municipal

|                             |                                                 |                  |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Código                      | PS-ND-35                                        | Versão           | 1.0 (minuta)  |
| Elaboração                  | Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986 | Data-base        | setembro/2026 |
| Aprovação (Diretor Clínico) | _____                                           | Vigência         | ___/___/___   |
| Aprovação (Coordenação PS)  | _____                                           | Revisão prevista | ___/___/___   |

#### 0. Escopo, premissas e fontes

Violência é problema de saúde e o PS é frequentemente o **primeiro e único contato** da pessoa agredida com o Estado. O atendimento tem quatro dimensões inseparáveis: **cuidar da lesão, proteger de novo dano (avaliação de risco e rede), documentar de forma que sirva à pessoa (prontuário, laudo, fotos) e cumprir os deveres legais (notificação e comunicação)**. Na violência sexual há um relógio: **profilaxias em até 72 h** (HIV, contracepção de emergência até 120 h, hepatite B, IST) — o PS não pode mandar embora para "fazer o BO primeiro". O princípio ético é o da pessoa como sujeito: escutar sem julgamento, informar, respeitar decisões (com as exceções legais para criança, adolescente, idoso e incapaz) e nunca condicionar o cuidado à denúncia.

**Fontes de ancoragem: Brasil. Ministério da Saúde. Prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes: norma técnica, 3ª ed. (2012) [MS-VS 2012]; MS. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Pós-Exposição (PEP) de risco à infecção pelo HIV, IST e hepatites virais (2021, atualizações 2024) [MS-PEP]; MS. PCDT de atenção integral às pessoas com IST (2022) [MS-IST]; MS. Linha de cuidado para a atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violências (2010) e *Guia de Vigilância em Saúde — violência interpessoal/autoprovocada* (ficha SINAN) [MS-GVS]; **Lei nº 11.340/2006 (Maria da Penha); Lei nº 13.931/2019** (comunicação obrigatória à polícia de indícios de violência contra a mulher atendida em serviços de saúde, em 24 h); Lei nº 12.845/2013 (atendimento obrigatório e integral às vítimas de violência sexual — SUS) e Decreto 7.958/2013; Lei nº 8.069/1990 (ECA, art. 13 e 245); Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso, art. 19); Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); Lei nº 13.819/2019 (prevenção do suicídio); Lei nº 14.321/2022 (violência institucional); Portaria GM/MS nº 1.271/2014 e 264/2020 (notificação compulsória); Resolução CFM nº 2.217/2018 (Código de Ética Médica — sigilo e dever legal); Portaria MS nº 485/2014 (serviços de referência à violência sexual); FEBRASGO — Violência sexual (2021); WHO. Responding to intimate partner violence and sexual violence against women: clinical and policy guidelines (2013) e Clinical management of rape and IPV survivors (2020).**

**Convenção de confiança:** condutas e doses conforme MS-PEP 2021/2024 e MS-VS 2012; **[VERIFICAR]:** kit de PEP (TDF/3TC/DTG), levonorgestrel, vacina/imunoglobulina de hepatite B, ceftriaxona/azitromicina/metronidazol/penicilina benzatina, testes rápidos (HIV, sífilis, HB, HC), serviço de referência em violência sexual da região (Santa Casa?)

## 1. Reconhecer — a violência raramente chega nomeada

Ela chega como "caí da escada", "bati na porta", "dor pélvica", "ITU de repetição", "crise de ansiedade", "tentativa de suicídio", "criança que não para de chorar", "idoso desnutrido com escaras", "adolescente com IST". Perguntar diretamente e em privado é a única forma de saber.

| Sinais de alerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Como perguntar (em privado, sem o possível agressor, sem julgamento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lesões incompatíveis com a história ou em estágios diferentes; lesões em locais protegidos (face interna de braços/coxas, dorso, orelhas, pescoço, mamas, genitália); marcas de objetos/mãos/dentes; queimaduras com padrão; lesões defensivas; atraso na procura; múltiplas idas ao PS; acompanhante que responde por ela/ele, controla, não deixa sozinho; medo, evasão, choro, olhar para o acompanhante antes de responder; sintomas psicossomáticos crônicos; IST/gravidez em criança/adolescente; adolescente com parceiro muito mais velho; criança com comportamento sexualizado, regressão, medo de ir para casa; idoso com higiene precária, desnutrição, escaras, medicações não dadas, "vem sozinho apesar de dependente" | Criar privacidade ("preciso examinar sozinho(a)"); iniciar de forma geral e depois direta: <b>"Como estão as coisas em casa?" "Alguém te machucou, ameaçou ou te obrigou a algo que você não queria?" "Isso que aconteceu com você foi feito por alguém?" "Você se sente seguro(a) para voltar para casa?"</b> ; acreditar; não confrontar o acompanhante; usar intérprete/LIBRAS se necessário; criança: linguagem simples, sem perguntas indutoras, poucas perguntas (o depoimento especial é da Justiça — o PS registra o relato espontâneo literal) |

## 2. Tipos de violência, avaliação de risco e deveres legais

### 2.1 Tipologia (SINAN) e o que muda

| Tipo                                                                                                                | Definição / exemplos                                                                                       | Deveres específicos                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Violência doméstica/familiar contra a mulher</b> (Lei 11.340/2006 — Maria da Penha)                              | Física, psicológica, sexual, patrimonial, moral, por parceiro/ex-parceiro/família r/coabitante             | Notificação SINAN (obrigatória); <b>comunicação à autoridade policial em 24 h (Lei 13.931/2019)</b> — <b>independentemente da vontade da mulher</b> , informando-a; oferecer rede (DEAM, medida protetiva, CREAS/CRM, Casa Abrigo); não condicionar o cuidado ao BO                             |
| <b>Violência sexual</b> (estupro, estupro de vulnerável <14 anos, assédio, exploração)                              | Qualquer ato sexual sem consentimento ou com incapaz de consentir                                          | Atendimento <b>imediato e integral</b> (Lei 12.845/2013): profilaxias, contracepção, coleta de vestígios se possível, notificação SINAN; menor de 18 anos: Conselho Tutelar; mulher: comunicação policial (13.931); orientar sobre BO/IML sem condicionar; aborto legal (art. 128 CP) informado |
| <b>Criança e adolescente</b> (ECA)                                                                                  | Física, sexual, psicológica, negligência, abandono, trabalho infantil, exploração, testemunho de violência | Notificação SINAN + <b>comunicação obrigatória ao Conselho Tutelar</b> (ECA art. 13; omissão = infração, art. 245); suspeita basta; não confrontar os pais; proteger no PS (não liberar com o suspeito) — internação de proteção se necessário                                                  |
| <b>Idoso</b> (≥60 anos — Estatuto do Idoso)                                                                         | Física, psicológica, financeira/patrimonial, negligência, abandono, autonegligência                        | Notificação SINAN + comunicação obrigatória (art. 19) a autoridade policial/MP/Conselho do Idoso; CREAS; avaliar capacidade e segurança para alta                                                                                                                                               |
| <b>Pessoa com deficiência</b>                                                                                       | Idem + violência institucional                                                                             | Notificação; comunicação (Lei 13.146, art. 26); acessibilidade no atendimento                                                                                                                                                                                                                   |
| Violência interpessoal comunitária (agressão, assalto, tortura, tráfico, LGBTfobia, racismo, violência no trabalho) | Fora do contexto doméstico                                                                                 | Notificação SINAN (violência interpessoal); orientar BO; motivação por raça/orientação sexual/identidade registrar                                                                                                                                                                              |
| <b>Violência autoprovocada</b> (tentativa de suicídio, automutilação)                                               | Protocolo 04                                                                                               | Notificação SINAN <b>imediata (24 h)</b> — Lei 13.819/2019; CAPS                                                                                                                                                                                                                                |
| Violência institucional (inclusive obstétrica)                                                                      | Lei 14.321/2022                                                                                            | Registro, ouvidoria, notificação                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 2.2 Avaliação de risco de nova agressão / morte (para decidir alta e rede)

| Fatores de alto risco (feminicídio/reincidência grave)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Conduta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ameaça de morte; uso/acesso a arma de fogo; tentativa de estrangulamento/asfixia ( <b>fator isolado mais associado a feminicídio</b> — examinar pescoço, voz, dispneia; considerar lesão de carótida/laringe); escalada de frequência/gravidade; agressão na gestação; separação recente/anunciada; ciúme extremo/controle; agressor com uso de álcool/drogas, antecedentes, desemprego recente; violência sexual pelo parceiro; agressão a filhos/animais; a própria pessoa avalia que pode ser morta; isolamento social; descumprimento de medida protetiva | Alto risco → <b>não dar alta para o mesmo domicílio sem plano</b> : acionar rede no PS (serviço social, CREAS/CRM, DEAM/plantão policial para medida protetiva de urgência, Casa Abrigo se necessário), internação de proteção/social se não houver alternativa segura no momento; plano de segurança escrito; contato de confiança; documentar o risco (Formulário Nacional de Avaliação de Risco — FRIDA/CNJ-CNMP) |

## 2.3 Sigilo, autonomia e dever legal — como conciliar (Código de Ética Médica art. 73; Lei 13.931; ECA; Estatuto do Idoso)

- **Adulto capaz (homem ou mulher fora do contexto Maria da Penha):** a notificação SINAN é epidemiológica e obrigatória (não é denúncia); o BO é decisão da pessoa — informar e apoiar. O médico não denuncia contra a vontade, salvo dever legal.
- **Mulher em violência doméstica/familiar (11.340) ou sexual:** Lei 13.931/2019 obriga o serviço a comunicar à polícia em 24 h os indícios — **a mulher deve ser informada** de que a comunicação será feita, o que ela significa (não obriga a processar) e de seus direitos; o cuidado e as profilaxias não dependem disso.
- **Criança/adolescente, idoso, pessoa com deficiência/incapaz:** comunicação obrigatória (Conselho Tutelar/autoridade) — a suspeita fundamentada basta; não é necessária certeza nem consentimento do responsável (que pode ser o agressor).
- Registrar em prontuário: relato literal entre aspas, quem contou, lesões descritas objetivamente (medidas, localização, cor, forma), fotos com consentimento (ou do responsável não suspeito), exames, condutas, comunicações feitas (a quem, hora, protocolo) e orientações. O prontuário é documento legal e será a prova mais importante — escrever para o juiz ler.
- Laudo pericial é do IML (Corpo de delito); o PS **não** substitui, mas o registro médico detalhado e o relatório de atendimento (cópia para a pessoa) têm valor probatório; a coleta de vestígios (swabs) no PS só se houver protocolo pactuado com o IML/serviço de referência [VERIFICAR] — a ausência de coleta nunca atrasa as profilaxias.

## 3. Exame físico e documentação

| Item                                               | Conduta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambiente e acompanhante                            | Sala reservada, porta fechada, profissional do gênero de preferência da pessoa quando possível, acompanhante de confiança (não o suspeito); criança: acompanhante que não seja o suspeito; explicar cada passo e pedir permissão                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Exame geral (ABCDE se trauma)                      | Protocolo 34/29; sinais vitais; sinais de intoxicação (drogas facilitadoras — "boa noite Cinderela": amnésia, sonolência); gestação ( $\beta$ -hCG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Lesões</b> — descrever sem interpretar a causa  | Tipo (equimose, hematoma, escoriação, laceração, queimadura, mordedura, marca de mão/objeto), <b>localização anatômica precisa, dimensões (cm), forma, cor (estágio), número</b> ; mapa corporal (diagrama); fotografias com régua/escala, identificação, data/hora, consentimento — armazenar no prontuário; lesões de defesa (antebraços), pescoço (estrangulamento: petéquias conjuntivais/faciais, marcas, rouquidão, disfagia — TC/angio-TC se sintomas), couro cabeludo, orelhas, mamas, genitália |
| <b>Exame ginecológico/anal na violência sexual</b> | Só com consentimento, explicando; inspeção (lacerações, hematomas, fissuras, sangramento — muitas vezes <b>normal</b> , o que não exclui); especular se necessário; coleta de secreções para IST se protocolo; criança pré-púbere: exame externo, sem especular/toque — se necessário, sob sedação na referência; documentar hímen de forma descritiva sem conclusões forenses                                                                                                                           |
| Criança/adolescente                                | Peso/estatura/estado nutricional, higiene, lesões em estágios diferentes, padrões (marcas de dedos, cinto, cigarro, queimadura em "luva/meia"), fraturas em <2 anos (esqueleto: RX de corpo inteiro na referência), hemorragia retiniana (fundo de olho — bebê sacudido), lesões orais/frênulo, comportamento; história incompatível com o desenvolvimento                                                                                                                                               |
| Idoso/pessoa com deficiência                       | Escaras, desnutrição, desidratação, higiene, contenção, medicação (super/subdosagem), lesões, estado cognitivo (capacidade), sinais de abuso financeiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Saúde mental                                       | Risco de suicídio (Protocolo 04), sintomas de estresse agudo; acolher sem pressionar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Relatório para a pessoa                            | Cópia do atendimento (descrição das lesões, condutas) — direito da paciente; encaminhamento ao IML (corpo de delito) orientado, não obrigatório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 4. Propedêutica — violência sexual e trauma

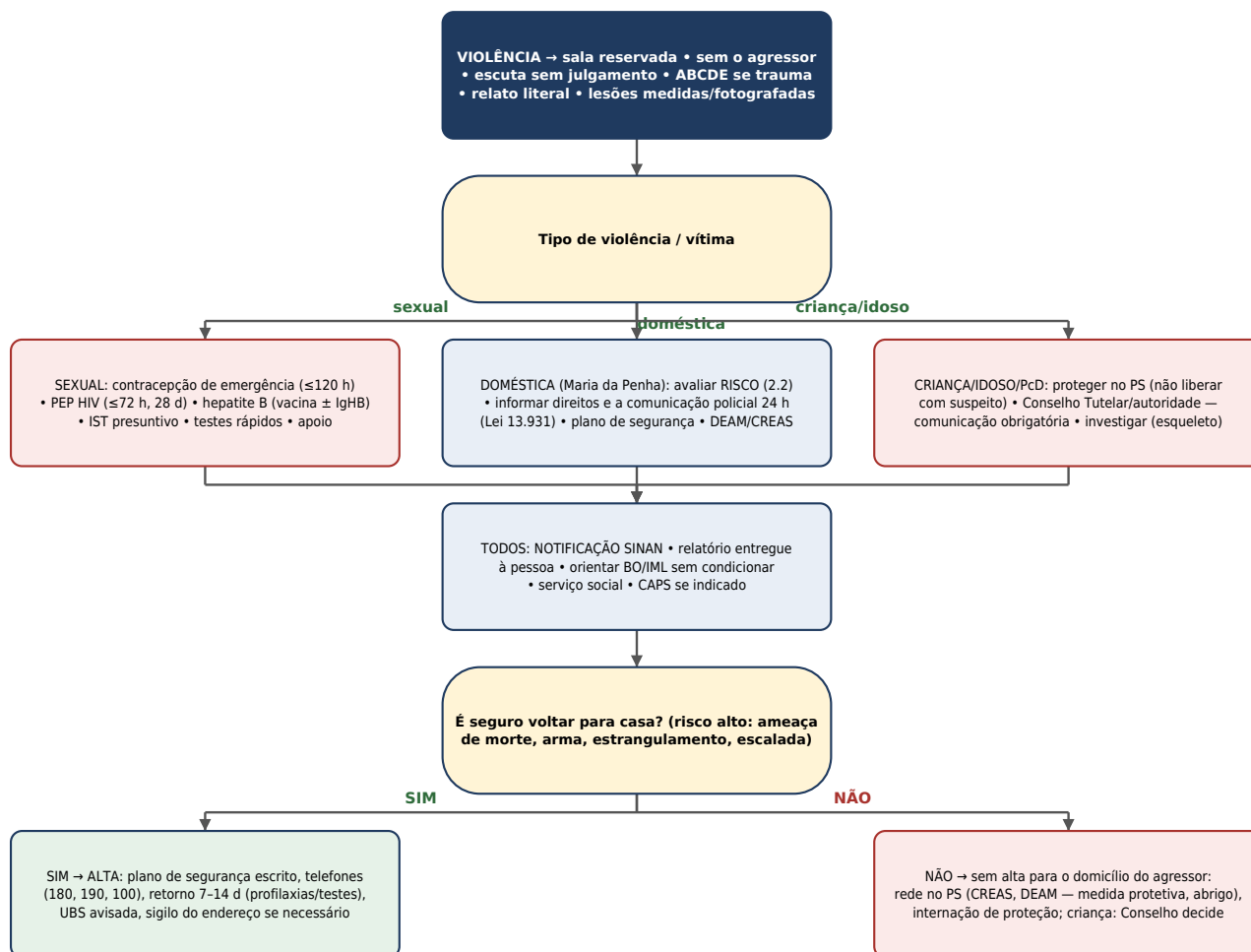
| Exame                                                                         | Para que serve                                                                                            | Quando                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>β-hCG</b>                                                                  | Gravidez prévia (contracepção de emergência não interrompe gestação; aborto legal se gestação decorrente) | Toda mulher em idade fértil                                                        |
| <b>Testes rápidos: HIV, sífilis, hepatite B (HBsAg) e C</b>                   | Estado basal (não é para decidir PEP — PEP começa antes do resultado); HBsAg define vacina/IgHB           | Chegada ( $\leq 72$ h) e seguimento (30/90 dias; sífilis 30 dias; HC 90 dias)      |
| Anti-HBs (se vacinado)                                                        | Imunidade → dispensa vacina/IgHB                                                                          | Se disponível                                                                      |
| Hemograma, creatinina, TGO/TGP                                                | Basal para antirretrovirais                                                                               | Ao iniciar PEP (não atrasa a 1ª dose)                                              |
| Pesquisa de IST (gonococo/clamídia — PCR de swab; tricomonas; bacterioscopia) | Documentação/tratamento dirigido                                                                          | Se disponível; tratamento é presuntivo de qualquer modo                            |
| Coleta de vestígios (swabs vaginal/anal/oral, roupas, unhas)                  | Perícia — cadeia de custódia                                                                              | Só com protocolo pactuado com IML [VERIFICAR]; $\leq 72$ h; não atrasa profilaxias |
| Toxicológico (urina/sangue)                                                   | Drogas facilitadoras (BZD, GHB, cetamina) — janela curta                                                  | Suspeita; se disponível/pactuado                                                   |
| RX de esqueleto, TC de crânio, fundo de olho                                  | Criança <2 anos com suspeita de maus-tratos (fraturas ocultas, hemorragia)                                | Referência (Santa Casa/pediatria)                                                  |
| Angio-TC de pescoço                                                           | Estrangulamento com sintomas (voz, disfagia, déficit, petéquias)                                          | Referência                                                                         |

## 5. Por que o tempo importa — profilaxias e trauma psíquico

O HIV estabelece infecção local em 24–48 h e sistêmica em ~72 h: a **PEP** iniciada em  $\leq 2$  h é mais eficaz, e após 72 h não é indicada. A **contracepção de emergência** com levonorgestrel age retardando/inibindo a ovulação — eficácia cai a cada dia (até 5 dias); não é abortiva. O vírus da hepatite B tem incubação longa: vacina  $\pm$  imunoglobulina em até 14 dias protegem. As IST bacterianas (sífilis, gonococo, clamídia, tricomonas) recebem tratamento presuntivo porque o diagnóstico é tardio e o seguimento incerto. No **estrangulamento**, a compressão de carótidas/jugulares por segundos causa perda de consciência e lesão hipóxica; dissecação carotídea e edema laríngeo podem se manifestar em horas-dias — daí a investigação quando há sintomas. A violência produz **trauma psíquico**: a resposta aguda (dissociação, hiperalerta, vergonha, culpa) é normal e modulada pela qualidade do primeiro atendimento — acolhimento não julgador, informação e controle sobre as decisões reduzem o risco de TEPT; revitimização (exame repetido, descrença, culpabilização, exposição) o aumenta. Na criança, a violência crônica altera o desenvolvimento neurológico e a saúde ao longo da vida (experiências adversas na infância) — a interrupção precoce pela rede de proteção é a intervenção de maior impacto que o PS pode desencadear.

## 6. Fluxo de atendimento

**Cuidar, proteger, documentar, comunicar.** A violência sexual tem relógio (profilaxias); a doméstica tem dever de comunicação; a criança/idoso tem dever de proteção. Nenhum deles condiciona o cuidado ao boletim de ocorrência.



■ Entrada    ■ Decisão    ■ Conduta    ■ Risco / atenção    ■ Desfecho / transferência

### 6.1 Metas de tempo

| Intervalo                                                                             | Meta                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chegada → acolhimento em sala reservada, triagem de risco                             | ≤15 min (prioridade na classificação)                                                      |
| Violência sexual → 1ª dose de PEP (se ≤72 h)                                          | <b>≤2 h da chegada</b> (ideal ≤2 h do evento; máximo 72 h)                                 |
| Violência sexual → contracepção de emergência                                         | ≤2 h (até 120 h do evento)                                                                 |
| Hepatite B → vacina ± IgHB                                                            | Mesmo atendimento (até 14 dias)                                                            |
| Notificação SINAN                                                                     | Ficha preenchida no atendimento; violência autoprovocada e contra criança: imediata (24 h) |
| Comunicação obrigatória (Conselho Tutelar / polícia — Lei 13.931 / Estatuto do Idoso) | ≤24 h, documentada (a quem, hora, protocolo)                                               |
| Avaliação de risco e plano de alta                                                    | Antes da alta — sem alta noturna sem rede/acompanhante em risco alto                       |

## 7. Condutas — violência sexual (adulto e adolescente) [MS-VS 2012; MS-PEP 2021/2024; MS-IST 2022]

### 7.1 Anticoncepção de emergência

| Método                           | Dose                                                                                                                                           | Observações                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Levonorgestrel                   | <b>1,5 mg VO dose única</b> (ou 0,75 mg 12/12 h) — <b>até 120 h</b> (5 dias) do evento; ideal ≤72 h                                            | Eficácia ~95% em 24 h, ~58% em 72–120 h; repetir se vômito em <2 h; não é abortiva; não contraindicada em nenhuma condição; oferecer a toda mulher/adolescente em idade fértil sem contracepção eficaz em uso, independentemente do ciclo |
| Alternativa (sem levonorgestrel) | Método de Yuzpe: etinilestradiol 100 mcg + levonorgestrel 500 mcg 12/12 h × 2 (ex.: 4 comprimidos de ACO 30/150 12/12 h) com antiemético       | Menos eficaz, mais náusea                                                                                                                                                                                                                 |
| DIU de cobre                     | Até 5 dias — serviço de referência                                                                                                             | Mais eficaz; não em violência sexual pelo risco de IST sem tratamento                                                                                                                                                                     |
| Gestação decorrente de estupro   | Informar o direito ao <b>aborto legal (art. 128, II, CP)</b> sem necessidade de BO; encaminhar ao serviço de referência [VERIFICAR — regional] | Portaria MS 2.561/2020 / normativa vigente; sigilo                                                                                                                                                                                        |

### 7.2 Profilaxia pós-exposição ao HIV (PEP) [MS-PEP]

| Item                                                  | Conduta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicação                                             | Violência sexual com penetração vaginal/anal/oral (com ejaculação) em <b>≤72 h</b> ; agressor desconhecido ou de status HIV desconhecido/positivo; <b>iniciar sem esperar exames</b> ; não indicar se >72 h (orientar testes de seguimento) ou se agressor sabidamente HIV negativo (teste rápido do agressor quando possível) |
| <b>Esquema (adulto e adolescente ≥12 anos/≥35 kg)</b> | <b>Tenofovir 300 mg + lamivudina 300 mg (TDF/3TC — 1 comprimido combinado) + dolutegravir 50 mg</b> , 1×/dia por <b>28 dias</b> ; gestante: mesmo esquema (DTG ok)                                                                                                                                                             |
| Criança (<12 anos ou <35 kg)                          | Esquemas por peso (zidovudina + lamivudina + dolutegravir/raltegravir/lopinavir-r) — <b>consultar MS-PEP e infectologia/pediatria</b> [dose lock]                                                                                                                                                                              |
| Antes de iniciar                                      | Teste rápido HIV (se positivo, encaminhar para tratamento — não PEP); creatinina, TGO/TGP, hemograma (não atrasam a 1ª dose); β-hCG                                                                                                                                                                                            |
| Dispensação                                           | 1ª dose no PS (não pode faltar no estoque — <b>kit de PEP [VERIFICAR]</b> ); prescrição para 28 dias; orientar adesão, efeitos (náusea, cefaleia — geralmente leves), interações (DTG: antiácidos com cátions — separar 2 h; metformina; anticonvulsivantes); retorno em 7–14 dias                                             |
| Seguimento                                            | Teste HIV em 30 e 90 dias; sífilis 30 dias; hepatites 90 dias; encaminhar ao serviço de referência/SAE                                                                                                                                                                                                                         |

### 7.3 Profilaxia de IST não virais e hepatite B [MS-IST 2022; MS-VS 2012]

| Agente                         | Adulto/adolescente                                                                                                                                                                                                                                         | Observações                                                                           |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sífilis</b>                 | <b>Penicilina G benzatina 2,4 milhões UI IM</b> (1,2 milhão em cada glúteo), dose única                                                                                                                                                                    | Alergia grave: doxiciclina 100 mg 12/12 h 15 dias (não em gestante — dessensibilizar) |
| <b>Gonococo</b>                | <b>Ceftriaxona 500 mg IM</b> dose única                                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                     |
| <b>Clamídia</b>                | <b>Azitromicina 1 g VO</b> dose única                                                                                                                                                                                                                      | Gestante: azitromicina ok                                                             |
| <b>Tricomonas</b> (e vaginose) | <b>Metronidazol 2 g VO</b> dose única (ou 500 mg 12/12 h 7 dias)                                                                                                                                                                                           | Evitar álcool 24 h; pode adiar 7–10 dias se náusea com PEP                            |
| <b>Hepatite B</b>              | <b>Vacina HB</b> (dose 0 no PS; 1 e 6 meses) se não vacinado/incompleto/desconhecido; + <b>imunoglobulina HB (IgHB) 0,06 mL/kg IM</b> (dose única, até 14 dias; ideal ≤48 h) se agressor HBsAg+ ou desconhecido e vítima não imune [VERIFICAR IgHB — CRIE] | Vacinado com esquema completo: nada; anti-HBs se disponível                           |
| Hepatite C, HPV, herpes        | Sem profilaxia; seguimento sorológico (HC 90 dias); vacina HPV se ≤45 anos e não vacinada (PNI: 9–14 anos; vítimas de violência sexual 15–45 anos)                                                                                                         | Orientar                                                                              |
| Criança pré-púbere             | Esquemas por peso (ceftriaxona 125–250 mg IM; azitromicina 20 mg/kg; metronidazol 15 mg/kg/dia; penicilina benzatina 50.000 UI/kg) — MS-VS/pediatria [dose lock]                                                                                           | Avaliar em serviço de referência pediátrica                                           |

### 7.4 Outros cuidados na violência sexual

- Tétano se ferida (Protocolo 27); analgesia; tratamento de lesões (sutura genital só por ginecologia/cirurgia; lesão anal grave → cirurgia).
- Apoio psicológico imediato (escuta, informação, previsibilidade); oferecer acompanhamento (psicologia/CAPS/serviço de referência); não prescrever BZD de rotina.
- Não exigir BO nem exame no IML como condição; informar sobre ambos e sobre a coleta de vestígios (ideal ≤72 h, sem banho) — a decisão é da pessoa (adulta); acionar serviço social.
- Registrar: hora/local/tipo de agressão, agressor (relação, número), uso de preservativo, ejaculação, drogas, higiene após, lesões, exames, profilaxias (nomes, doses, lotes, horas), orientações, comunicações.

## 8. Rede, encaminhamentos, alta e indicadores

### 8.1 Rede de proteção — telefones e fluxos [VERIFICAR e afixar]

| Serviço                                                                                                      | Função                                                                                                                 | Contato                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conselho Tutelar de Estiva Gerbi</b>                                                                      | Criança/adolescente: comunicação obrigatória, decide destino/proteção                                                  | _____ (24 h?)<br>[VERIFICAR]                                                            |
| <b>Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Mogi Guaçu / plantão policial</b>                                  | BO, medida protetiva de urgência (Maria da Penha — pode ser solicitada pela Delegacia/Juizado), comunicação Lei 13.931 | _____; 180 (Central de Atendimento à Mulher); 190                                       |
| <b>CREAS / CRAS</b> (Estiva Gerbi / regional)                                                                | Acompanhamento psicossocial, abrigo, benefícios, idoso/PcD                                                             | _____                                                                                   |
| <b>Serviço de referência em violência sexual</b> (Portaria 485/2014)                                         | Coleta de vestígios, PEP/seguimento, aborto legal, psicologia                                                          | [VERIFICAR: hospital de referência regional — Campinas (CAISM)? Santa Casa Mogi Guaçu?] |
| <b>IML</b>                                                                                                   | Corpo de delito (adulto: após BO; criança: via Conselho/polícia)                                                       | _____                                                                                   |
| <b>CAPS / CAPSi / CAPS AD</b>                                                                                | Saúde mental, risco de suicídio, uso de substâncias                                                                    | _____                                                                                   |
| Vigilância Epidemiológica municipal                                                                          | Recebe as fichas SINAN; articula rede                                                                                  | _____                                                                                   |
| Ministério Público / Defensoria Pública / Juizado de Violência Doméstica                                     | Medidas protetivas, idoso, PcD                                                                                         | _____                                                                                   |
| Disque 100 (Direitos Humanos), Disque 180 (Mulher), Ligue 190 (Polícia), 192 (SAMU), 100 (criança/idoso/PcD) | Canais nacionais 24 h                                                                                                  | —                                                                                       |
| UBS/ESF do território (ACS)                                                                                  | Busca ativa, seguimento, vigilância domiciliar                                                                         | Informar a equipe (com o consentimento possível)                                        |

### 8.2 Alta — pacote

- Só após: lesões tratadas, profilaxias iniciadas/dispensadas, notificação preenchida, comunicações obrigatórias feitas e documentadas, avaliação de risco com plano de segurança, relatório de atendimento entregue, retorno agendado (7-14 dias: PEP/testes/lesões) e serviço de referência/CAPS acionados quando indicado.
- Plano de segurança** (escrito, com a pessoa): para onde ir se houver nova agressão, quem chamar, documentos/chaves/dinheiro separados, código com vizinho/familiar, telefones; orientar sobre medida protetiva e que a comunicação policial foi/será feita.
- Criança: alta só com destino definido pelo Conselho Tutelar/responsável não suspeito; idoso dependente: não devolver ao cuidador suspeito sem rede.
- Sigilo: endereço/telefone protegidos no prontuário se risco; não fornecer informações ao suspeito.

### 8.3 O que o PS precisa ter

- Sala reservada; fichas SINAN (violência interpessoal/autoprovocada) e fluxo de envio; formulário de avaliação de risco (FRIDA/CNJ); modelo de relatório de atendimento; máquina fotográfica/celular institucional com régua; kit de coleta de vestígios se pactuado.
- Estoque 24 h: **kit PEP (TDF/3TC + DTG — 28 dias ou ao menos a 1ª dose + receita)**, levonorgestrel 1,5 mg, penicilina benzatina, ceftriaxona, azitromicina, metronidazol, vacina HB, IgHB (ou fluxo CRIE), testes rápidos (HIV, sífilis, HB, HC),  $\beta$ -hCG, dT/SAT.
- Lista de contatos da rede afixada e atualizada; treinamento anual da equipe (acolhimento, documentação, deveres legais); serviço social ou fluxo de referência; protocolo pactuado com Conselho Tutelar, DDM, CREAS, vigilância e serviço de referência em violência sexual.

## 8.4 Indicadores de qualidade (auditoria mensal)

| Indicador                                                                                                                            | Meta |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| % de atendimentos por violência com ficha SINAN preenchida (e enviada) no atendimento                                                | 100% |
| % de violência sexual ≤72 h com PEP iniciada em ≤2 h da chegada e contracepção de emergência oferecida                               | 100% |
| % de violência sexual com profilaxia de IST + hepatite B documentadas                                                                | ≥95% |
| % de criança/adolescente/idoso com comunicação obrigatória documentada (a quem/hora/protocolo)                                       | 100% |
| % de mulheres (Maria da Penha) com comunicação Lei 13.931 documentada e informada à paciente                                         | 100% |
| % com avaliação de risco e plano de segurança antes da alta                                                                          | ≥90% |
| % com lesões descritas (localização/dimensão) e fotografadas com consentimento                                                       | ≥90% |
| % com retorno agendado (7-14 dias) e serviço de referência/CAPS acionado quando indicado                                             | ≥90% |
| Alta de vítima de alto risco para o domicílio do agressor sem rede acionada; profilaxia negada por "falta de BO" (eventos sentinela) | 0    |

## 9. Divergências, tensões éticas e itens a verificar antes da aprovação

| Tema                                                                         | Posição declarada                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comunicação policial x autonomia da mulher (Lei 13.931/2019 vs. CEM art. 73) | A lei impõe o dever ao serviço; o CFM reconhece o dever legal como exceção ao sigilo. Adotado: comunicar em 24 h, <b>sempre informando a mulher</b> , sem condicionar o cuidado e sem comunicar o agressor; registrar o diálogo |
| Esquema de PEP                                                               | MS 2021/2024: TDF/3TC + DTG por 28 dias (adultos, adolescentes ≥35 kg, gestantes). Adotado; esquemas pediátricos exigem consulta                                                                                                |
| Contracepção de emergência — janela                                          | MS: até 5 dias (120 h); eficácia decrescente. Adotado; DIU de cobre não na violência sexual                                                                                                                                     |
| IgHB                                                                         | Indicada se agressor HBsAg+/desconhecido e vítima não imune, até 14 dias — disponibilidade via CRIE [VERIFICAR]                                                                                                                 |
| Coleta de vestígios no PS                                                    | Lei 12.845 prevê; exige protocolo e cadeia de custódia com IML — só se pactuado [VERIFICAR]; nunca atrasa profilaxias                                                                                                           |
| Aborto legal                                                                 | Direito garantido (CP art. 128) sem BO; fluxo do serviço de referência regional [VERIFICAR]                                                                                                                                     |
| Exame de criança                                                             | Sem especular/toque em pré-púbere; investigação (esqueleto, fundo de olho) na referência; depoimento é da Justiça (Lei 13.431/2017 — escuta especializada) — o PS registra o relato espontâneo                                  |
| Internação de proteção                                                       | Sem norma específica; prática aceita quando não há alternativa segura — pactuar com serviço social/Conselho/MP [VERIFICAR]                                                                                                      |
| Contatos da rede local                                                       | <b>Todos os telefones e fluxos devem ser preenchidos e afixados</b> [VERIFICAR/PACTUAR] — sem isso o protocolo é inexecutável                                                                                                   |

## 10. Referências

- Brasil. Ministério da Saúde. Prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes: norma técnica. 3ª ed. Brasília, 2012. Brasil. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Pós-Exposição (PEP) de risco à infecção pelo HIV, IST e hepatites virais. Brasília, 2021 (atualizações 2024). Brasil. Ministério da Saúde. PCDT para atenção integral às pessoas com IST. Brasília, 2022.
- Brasil. Ministério da Saúde. Linha de cuidado para a atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violências. Brasília, 2010. Guia de Vigilância em Saúde (edição vigente) — Violência interpessoal/autoprovoçada; Ficha de notificação SINAN. Portarias GM/MS nº 1.271/2014, 264/2020 (notificação compulsória), 485/2014 (serviços de referência à violência sexual), 2.561/2020 (aborto legal).
- Brasil. Lei nº 11.340/2006 (Maria da Penha); Lei nº 13.931/2019; Lei nº 12.845/2013 e Decreto nº 7.958/2013; Lei nº 8.069/1990 (ECA); Lei nº 13.431/2017 (escuta especializada); Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); Lei nº 13.819/2019; Lei nº 14.321/2022; Código Penal, art. 128. Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 2.217/2018 (Código de Ética Médica), arts. 73–79. CNJ/CNMP. Formulário Nacional de Avaliação de Risco (FRIDA), Resolução Conjunta nº 5/2020.
- Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Violência sexual: atendimento (Orientações e Recomendações FEBRASGO), 2021. World Health Organization. Responding to intimate partner violence and sexual violence against women: WHO clinical and policy guidelines. Geneva, 2013. WHO. Clinical management of rape and intimate partner violence survivors: developing protocols for use in humanitarian settings. Geneva, 2020.
- Velasco IT, et al. (eds.). *Medicina de Emergência: abordagem prática — HC-FMUSP*. Manole, edição vigente — capítulo de violência sexual (página não conferida). Framework clínico institucional — módulo de documentos formais (framework\_v3\_mod\_documentos\_formais).

---

**Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986**

Responsável técnico pela elaboração